

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Abitibi-Témiscamingue

Dossier : 620479-08-1610

Dossier CNESST : 142868066

Rouyn-Noranda, le 7 août 2017

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Josée Audet

Gertrude Grenier
Partie demanderesse

et

Buffet Dragon de l'Orient
Partie mise en cause

et

**Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail**
Partie intervenante

DÉCISION

[1] Le 31 octobre 2016, madame Gertrude Grenier (la travailleuse) dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif par lequel elle conteste une décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 29 septembre 2016, à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la Commission confirme celle initialement rendue le 3 juin 2016 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de récidive, de rechute ou d'aggravation le 22 janvier 2016.

[3] Depuis le 1^{er} janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail assume les compétences autrefois dévolues à la CSST

[4] Une audience s'est tenue à Val-d'Or le 16 mai 2017 en présence de la travailleuse et du représentant de la partie intervenante et le dossier a été mis en délibéré à cette date.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5] La travailleuse demande au Tribunal de déclarer qu'elle a subi, le 22 janvier 2016, une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 2 septembre 2014.

LES FAITS

[6] La travailleuse qui est préposée à l'entretien ménager subit une lésion professionnelle le 2 septembre 2014, alors qu'elle glisse sur la tuile mouillée de la cuisine.

[7] Aux notes de triage du centre hospitalier, on lit que la travailleuse se plaint de douleurs au bras gauche, à l'avant-bras gauche, à l'épaule et au coude gauches.

[8] La travailleuse est d'abord examinée par le docteur Nakhostine qui demande des examens par radiographie dont les résultats révèlent une fracture de la cinquième côte gauche.

[9] Les diagnostics posés sont donc ceux de douleur à l'épaule gauche et de fracture de la cinquième côte gauche.

[10] Le 1^{er} octobre 2014, près d'un mois après la survenance de la lésion initiale, une agente de la CSST communique avec l'agente pour s'enquérir de son état. La travailleuse lui dit entre autres que :

T dit que sa douleur est inexplicable. Elle devient tellement forte qu'elle perd l'équilibre et qu'elle a des nausées. T dit que depuis son accident cela fait 3 fois qu'elle perd l'équilibre. Nous lui suggérons d'en parler avec son médecin. Elle dit que le médecin lui a prescrit une attelle qu'elle ne porte pas car cela lui donne des nausées. Elle ne s'explique pas vraiment pourquoi. Le médecin lui aurait aussi prescrit de la codéïne qu'elle a refusé car elle dit que par le passé elle a déjà essayé d'en prendre et elle venait confuse avec cette médication. Elle dit qu'elle préfère prendre des acétaminophènes.

Dit que la nuit c'est l'enfer. Elle n'a aucune position pour dormir. Elle a de la difficulté à se tourner, Dit qu'elle se parle tout seul la nuit. Questionné à savoir elle évalue sa douleur à combien sur une échelle de 0 à 10 zéro étant aucune douleur 10 étant une douleur insupportable. Elle dit qu'elle l'évalue à 20/10 douleur plus qu'extrême.

[sic]

[11] Une contusion à l'épaule gauche est par la suite reconnue, le 6 octobre 2014, comme étant en lien avec la lésion professionnelle du 2 septembre 2014.

[12] Le 24 novembre 2014, le docteur Prévost pose le diagnostic de douleur à l'épaule gauche, de cervicalgie et de paresthésies au membre supérieur gauche. Il demande un examen par résonance magnétique.

[13] Le 9 décembre 2014, la travailleuse subit cet examen par résonance magnétique cervicale dont les résultats ne révèlent aucune lésion suspecte, si ce n'est une possible fine atteinte focale démyélinisante.

[14] L'examen par résonance magnétique de l'épaule gauche, quant à lui, est interprété comme ne révélant aucune évidence de déchirure de coiffe, mais une légère tendinose des sus et sous-épineux, et des fractures costales gauches en voie de consolidation.

[15] Le 26 janvier 2015, le docteur Prévost ajoute le diagnostic de tendinopathie du sous et du sus-épineux et dirige la travailleuse en physiothérapie. L'avis motivé du médecin qui a charge de la travailleuse signé par ce dernier indique qu'il y a amélioration de l'état de la travailleuse. Les traitements cessent le 13 mai 2015 en raison de l'atteinte d'un plateau.

[16] Le 15 mai 2015, le docteur Prévost pose des diagnostics de tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, de douleur chronique et de limitation de mouvements.

[17] Le 11 août 2015, le docteur Condé signe une attestation médicale où il indique que la travailleuse est tombée à domicile et souffre d'une contusion au bassin droit et il écrit : « lien avec douleur chronique pour laquelle la travailleuse est traitée ??? ». Et il ajoute que la douleur de la travailleuse a augmenté à la suite d'une chute.

[18] Le 28 août 2015, la travailleuse est examinée par le docteur Bah, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST.

[19] Au moment de son examen, la travailleuse est toujours en arrêt de travail, et elle prend alors de l'hydromorphine, de l'Élavil et du Tylenol. Elle indique au docteur Bah que

les traitements de physiothérapie ne lui ont apporté aucune amélioration. D'ailleurs, selon sa déclaration au médecin ce jour-là, l'état de sa côte comme de son épaule gauche ne s'est pas amélioré depuis l'accident, et sa douleur, ressentie sous une forme d'échauffement, est constante, et la travailleuse l'évalue à 10/10.

[20] À la discussion, le docteur Bah note :

A l'examen objectif effectué ce jour, on note une douleur diffuse à la palpation de toute l'épaule gauche, avec limitation de mouvements secondaire à une surprotection. Il est difficile de faire les tests spécifiques de l'épaule gauche. Au niveau de la région thoracique, on ne note pas de déformation. Il n'y a pas de volet thoracique. Madame rapporte une douleur au côté droit et au côté gauche.

[21] Le docteur Bah retient les diagnostics de fracture de la cinquième côte gauche et contusion de l'épaule gauche, il consolide les lésions le jour de son examen, sans nécessité de soins ou de traitements au-delà de cette date, et sans limitations fonctionnelles. Il accorde cependant un déficit anatomo-physiologique de l'ordre de 5,5 %, en se basant sur les limitations de mouvements notés en physiothérapie, puisque son examen objectif lui a permis de noter de limitations de mouvements, mais uniquement en raison d'une surprotection. Le pourcentage d'atteinte permanente sera par la suite ajusté à 6,5 % en raison d'une non-conformité au barème.

[22] Le 2 octobre 2015, le docteur Prévost signe un rapport complémentaire dans lequel il signale son désaccord au sujet du diagnostic et des limitations fonctionnelles.

[23] C'est dans ce contexte que la travailleuse est dirigée vers le Bureau d'évaluation médicale où elle est examinée par le docteur Ortaaslan, orthopédiste. Dans le cadre de son examen objectif, il note les symptômes suivants :

[...]

Il existe une sensibilité dans l'ensemble de l'épaule gauche, postérieur, supérieur, latéral et antérieur. Il n'y a aucune asymétrie au niveau des côtes ou du tronc droit ni gauche. Madame décrit une douleur diffuse dans l'entier du côté du tronc gauche. Il n'y a pas d'évidence d'inflammation cutanée ou spasme musculaire. La région de la cinquième côte n'est pas plus ou moins sensible que les autres régions du côté gauche. La sensation est normale au niveau du tronc et au niveau des deux membres supérieurs.

[...]

[24] Le docteur Ortaaslan retient les diagnostics de fracture de la cinquième côte gauche et de contusion à l'épaule gauche et il décrit les limitations fonctionnelles suivantes pour l'épaule gauche seulement :

Pour l'épaule gauche, la patiente doit éviter d'une manière répétitive:

- la surélévation du membre supérieur gauche dépassant 90° de flexion antérieure ou d'abduction;
- de soulever des charges dépassant 10 kg avec le membre supérieur gauche.

[25] Une attestation médicale datée du 23 janvier 2016 est signée par le docteur Goudreau. À la section du diagnostic on peut lire :

douleurs chroniques épaule G [gauche] + thorax G + hanche G X [depuis] chute 2014-09.
Douleur en (ici faire une flèche vers le haut svp Constance merci!) X 3-4 sem [semaines].
Analgésie déjà en place. Arrêt travail jusqu'à suivi avec Md [médecin] de famille.

[26] À la section destinée aux commentaires, le docteur Goudreau ajoute qu'il n'y a pas eu de facteur précipitant et qu'il y a une douleur diffuse au niveau du thorax gauche, à la hanche et à la crête iliaque gauche. L'état de la travailleuse est noté comme étant détérioré.

[27] Le 23 février 2016, le docteur Nakhostine pose les diagnostics d'exacerbation de tendinite de l'épaule gauche et de bursite trochantérienne de la hanche gauche. Il prescrit de la médication anti-inflammatoire et un arrêt de travail de sept jours. Le docteur Nakhostine n'indique pas sur l'attestation médicale de date précise pour la survenance d'une récurrence, d'une rechute ou d'une aggravation.

[28] Le 2 mars 2016, la travailleuse consulte à nouveau le docteur Nakhostine qui diagnostique une tendinite de l'épaule gauche et de la hanche gauche. Il indique comme date de récurrence, de rechute ou d'aggravation le 23 février 2016. Le médecin prescrit des infiltrations, un arrêt de travail de deux semaines et il prévoit une consolidation dans deux semaines. L'état de la travailleuse est alors noté comme stable.

[29] Le 13 mars 2016, le docteur Nakhostine signe une attestation médicale où il pose des diagnostics de tendinite à l'épaule gauche et de douleur à la hanche gauche. Il évalue l'état de la travailleuse comme stable.

[30] Le 4 avril 2016, le docteur Prévost pose quant à lui le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs et de bursite trochantérienne de la hanche gauche. L'état de la travailleuse est noté comme détérioré.

[31] Sur sa réclamation du 25 avril 2016, la travailleuse indique le 23 février 2016 comme date de récurrence, de rechute ou d'aggravation et elle décrit que le 22 février 2016, après avoir travaillé pendant 1 h 30 avec de la douleur, cette dernière a empiré à l'épaule gauche et à la hanche gauche. Elle écrit alors qu'elle a cessé de travailler, qu'elle a fait appel à son mari pour qu'il vienne la chercher et qu'elle est allée consulter à l'urgence.

Elle relie les douleurs aux conséquences de son accident de travail survenu le 2 septembre 2014.

[32] Le 31 mai 2016, le médecin-conseil de la Commission, la docteure Brien, donne son avis au sujet de la réclamation de la travailleuse :

Considérant que l'IRM du 09-12-2014 démontrait une condition de tendinose de la coiffe, c'est à dire une dégénérescence;
considérant que le Dx [diagnostic] de tendinite avait été soumis par le MD [médecin traitant] traitant dans le dossier d'origine mais non retenu par le BEM (Bureau d'évaluation médicale).
considérant que le seul Dx retenu pour l'épaule G par le BEM était une contusion

[...]

considérant que cette contusion a été consolidée le 28-08-2015 , soit il y a plus de 7 mois
considérant qu'il est médicalement reconnu qu'on ne peut récidiver, rechuter ou aggraver une contusion résolue 7 mois auparavant.
considérant que le Dx de bursite trochantérienne G (hanche G) concerne un site anatomique différent des Dx acceptés à l'EO [l'évènement d'origine]
considérant que ce Dx survient près de 2 ans après la survenue de l'EO
à mon avis il n'y a aucun élément en faveur d'une ARA acceptable en relation avec l'EO du 02-09-2014 dans ce dossier.

[sic]

[33] Et la réclamation de la travailleuse est refusée 3 juin 2016. La travailleuse a contesté cette décision jusqu'au présent tribunal, menant au litige en l'espèce.

[34] La travailleuse témoigne à l'audience. Elle explique qu'elle a toujours conservé de la douleur depuis la survenance de la lésion initiale. Elle ressent beaucoup de douleur, dit-elle.

[35] En réponse aux questions du procureur de la Commission, la travailleuse admet qu'elle chute souvent, et que ce sont surtout ses douleurs à la hanche qui l'incommodent. Elle décrit de la douleur à l'arrière de la hanche gauche de même qu'à l'épaule gauche. Elle est suivie par le docteur Adam, orthopédiste, qui, dit-elle, ne veut pas toucher à sa hanche. Elle affirme qu'elle ne peut plus rien faire. Selon elle, le médecin du Bureau d'évaluation médicale l'a mal examinée. L'ensemble du témoignage de la travailleuse démontre qu'elle est très mécontente du traitement de son dossier à la Commission depuis sa réclamation pour récurrence, rechute ou aggravation.

[36] Le conjoint de la travailleuse témoigne à l'audience. Il affirme que la travailleuse tombe souvent, que sa qualité de vie est affectée depuis la survenance de sa lésion professionnelle. Il affirme que la travailleuse a de la difficulté à marcher, qu'elle a besoin

de s'appuyer sur lui pour se déplacer. Que le docteur Prévost lui a dit qu'il fallait qu'elle apprenne à vivre avec ses douleurs.

[37] Enfin, la travailleuse dépose en preuve à l'audience des attestations médicales plus récentes signées par le docteur Prévost et l'orthopédiste Adam. Elles couvrent la période de mai 2016 à mars 2017. On peut y lire que la travailleuse continue d'être très symptomatique et que les symptômes et les diagnostics posés concernent graduellement non plus l'épaule gauche, mais la hanche gauche et la région lombaire. Par exemple, l'attestation médicale signée par le docteur Adam, orthopédiste, le 9 mars 2017, indique des diagnostics de bursite de la hanche gauche et de lombalgie. De plus, le docteur Adam ne mentionne pas de date de récurrence, de rechute ou d'aggravation, se bornant à inscrire que le 2 septembre 2014 est la date de l'évènement initial.

LES MOTIFS

[38] Le Tribunal doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, sous la forme d'une récurrence, d'une rechute ou d'une aggravation, le 22 janvier 2016 de sa lésion professionnelle initiale du 2 septembre 2014.

[39] La lésion professionnelle est définie à l'article de 2 de *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles* (la loi)¹ :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **lésion professionnelle** » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récurrence, la rechute ou l'aggravation;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[40] En l'espèce, le travailleuse allègue avoir subi une récurrence, une rechute ou une aggravation. La loi ne définit pas ce concept. C'est donc la jurisprudence qui en a établi les balises. Ainsi, pour qu'une récurrence, une rechute ou une aggravation soit reconnue, le travailleur doit faire la preuve prépondérante de la modification de sa condition de santé par rapport à celle qui existait au moment de la consolidation de sa lésion initiale² d'une part et la preuve qu'il y a relation entre cette modification et la lésion initiale ou l'évènement, d'autre part.

¹ RLRQ, c. A-3.001.

² *Beauchamp et Inspec-Sol*, [2009] C.L.P. 93.

[41] Ainsi, on précise dans *Beauchamp et Inspec-Sol*³, que :

[49] Les expressions « récurrence, rechute ou aggravation » n'étant pas définies à la loi, la jurisprudence a retenu le sens courant de ces termes et a établi que ceux-ci signifiaient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion initiale ou de ses symptômes.

[50] Cette première désignation implique donc nécessairement qu'il y ait modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation de la lésion et que celle-ci en découle.

[42] Quant à ce qui correspond à la preuve d'une telle modification de la condition de santé du travailleur, l'affaire *Dubé et Entreprises du Jalaumé enr*⁴ enseigne que :

[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l'état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n'est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l'apparition, de la réapparition ou de l'intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu'ils sont fiables. Cette question relève en réalité de l'appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l'état de santé. Il n'est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l'imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

[nos soulignements]

[43] Dans un deuxième temps, une fois que cette modification est démontrée, le travailleur doit également faire la preuve prépondérante qu'il y a relation entre la modification démontrée et la lésion initiale.

[44] Aux fins d'établir cette relation, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a depuis longtemps élaboré une série de critères bien connus dans l'affaire *Boisvert et Halco*⁵ afin de guider le Tribunal :

Certains paramètres permettent de déterminer l'existence d'une relation entre la récurrence, rechute ou aggravation alléguée et l'événement initial :

- 1- la gravité de la lésion initiale;
- 2- la continuité de la symptomatologie;
- 3- l'existence ou non d'un suivi médical;
- 4- le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;

³ *Id.*

⁴ C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

⁵ [1995] C.A.L.P. 19.

- 5- la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
- 6- la présence ou l'absence de conditions personnelles;
- 7- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- 8- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d'une réclamation.

[45] Quant à la nature de la preuve de relation, la Commission des lésions professionnelles précise dans la décision *Rivest et Star Appetizing products inc.*⁶ que :

[...]

Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu'elle revêt, c'est qu'elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde.

[...]

[46] La Commission des lésions professionnelles précise de plus dans cette décision que dans le cadre de son analyse, le Tribunal ne doit pas se limiter à examiner la relation entre le diagnostic posé lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation alléguée et le diagnostic de la lésion initiale, mais bien aussi la relation avec la lésion initiale elle-même ou l'évènement. Ainsi, on y lit que :

[25] Toutefois la preuve de relation ne peut pas être restreinte exclusivement à une preuve de relation avec le diagnostic de l'évènement d'origine. D'une part, d'autres éléments sont à considérer : le fait accidentel initial lui-même, le site de la lésion, la nature du diagnostic posé, les symptômes initialement rapportés, les signes cliniques observés, l'évolution de la symptomatologie et les résultats des examens lorsqu'une investigation plus poussée a lieu.

[47] Aux fins de rendre sa décision, le Tribunal est lié par l'avis du médecin qui a charge de la travailleuse s'il n'y a pas de procédure d'évaluation médicale, et ce, en vertu de l'article 224 de la loi.

[48] Les diagnostics de tendinite de l'épaule gauche et de bursite de la hanche gauche sont posés par plusieurs médecins ayant examiné la travailleuse à compter de janvier 2016. Ils n'ont pas été contestés et ils lient le Tribunal en l'absence d'une procédure d'évaluation médicale.

⁶ C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, requête en révision rejetée.

[49] Le Tribunal doit maintenant déterminer s'il y a modification de la condition médicale de la travailleuse en comparaison avec celle qui existait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle, soit le 28 août 2015.

[50] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que la modification de la condition médicale de la travailleuse a été démontrée de façon prépondérante.

[51] En effet, la preuve révèle une différence dans la symptomatologie de la travailleuse à compter de janvier 2016 alors que la première consultation évoque une tendinite de l'épaule gauche et une douleur à la hanche. L'état de la travailleuse est noté comme s'étant détérioré en janvier et février 2016, et les médecins qui l'examinent lui prescrivent un arrêt de travail et de la médication.

[52] C'est pourquoi le Tribunal est d'avis qu'il y a eu modification de la condition médicale de la travailleuse à compter de janvier 2016.

[53] Cependant, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de relation entre cette modification et la lésion initiale. En effet, en analysant la preuve à la lumière des critères de l'arrêt *Boisvert et Halco*⁷, le Tribunal retient d'abord que les diagnostics posés à compter de janvier 2016, soit ceux de tendinite à l'épaule droite et de bursite trochantérienne de la hanche gauche, sont différents de ceux posés par les médecins dans le cadre du traitement de la lésion initiale. De plus, le médecin membre du Bureau d'évaluation médicale n'a pas retenu d'autre lésion à l'épaule que la contusion. Par surcroît, aucun signe clinique d'atteinte à la hanche gauche n'a été identifié dans le cadre de l'évolution de la lésion initiale. Rien à ce sujet n'a non plus été allégué par la travailleuse à cette période.

[54] De plus, la preuve révèle que la lésion initiale a été consolidée en août 2015 et a laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à l'épaule gauche seulement. D'ailleurs, ces limitations fonctionnelles ne sont pas notées par le médecin examinateur comme telles. En effet, ce dernier se réfère aux notes de physiothérapie, compte tenu du phénomène de surprotection noté lors de son examen. De toute façon, les symptômes identifiés en janvier 2016 par le docteur Goudreau ne se situent pas à l'épaule gauche, mais à la hanche gauche, à la crête iliaque gauche, et au thorax à gauche. Et aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle n'a été retenue pour la région thoracique. Enfin, la récurrence, la chute ou l'aggravation alléguée survient sept mois après la consolidation de la lésion.

⁷

Précitée note 5.

[55] Le Tribunal constate également que la travailleuse n'a noté aucune amélioration de son état malgré son arrêt de travail et que les traitements qu'elle a subis n'ont pas non plus fait en sorte qu'elle se sente mieux.

[56] Par ailleurs, selon le dossier médical de la travailleuse, lors des consultations de février et mars 2016, son état est noté comme stable et elle est mise en arrêt de travail. Par la suite, au début d'avril 2016, alors qu'elle ne travaille pas, son état est noté comme s'étant détérioré.

[57] Le Tribunal ne peut ignorer non plus que les plaintes de la travailleuse à l'audience concernent bien davantage des douleurs à la hanche gauche. Or, rien ne permet de faire de lien probable entre la chute de la travailleuse en 2014 et la bursite de la hanche gauche, selon le dossier médical de la travailleuse.

[58] Le Tribunal doit également tenir compte du fait que l'évolution de la condition de la travailleuse démontre que les sièges de lésions à compter de 2016 s'éloignent de plus en plus du siège de la lésion initiale, qui, rappelons-le, avait mené à des diagnostics de contusion à l'épaule gauche et de fracture d'une côte. Cet élément ne milite pas non plus en faveur de la relation.

[59] D'ailleurs à ce sujet, il ne figure aucune preuve médicale au dossier qui permettrait de conclure à un lien entre les lésions diagnostiquées en 2016 et la lésion initiale de 2014, la seule opinion claire à ce sujet au dossier étant celle de la docteure Brien, médecin-conseil à la Commission, et elle est d'avis qu'il n'y a pas de tel lien.

[60] La preuve démontre que la travailleuse invoque dans sa réclamation la survenance d'une récurrence, d'une rechute ou d'une aggravation le 23 février 2016. La Commission a considéré la réclamation comme invoquant une telle lésion survenue le 22 janvier 2016 en raison de l'attestation médicale du 23 janvier 2016. À ce sujet, le Tribunal précise qu'il ne figure pas davantage au dossier de preuve prépondérante démontrant la survenance d'une récurrence, d'une rechute ou d'une aggravation qui serait survenue le 23 février 2016, et ce, pour les mêmes motifs que ceux plus haut exposés.

[61] Pour toutes ces raisons, et malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve pour la situation de la travailleuse, qui de toute évidence souffre, le Tribunal doit conclure que la travailleuse ne s'est pas acquittée du fardeau qui était le sien de démontrer par une preuve prépondérante qu'elle a subi, le 22 janvier 2016, ou le 23 février 2016, une récurrence, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 2 septembre 2014.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la contestation de la travailleuse, madame Gertrude Grenier;

CONFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail le 29 septembre 2016 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Gertrude Grenier, n'a pas, ni le 22 janvier 2016, ni le 23 février 2016, subi de récidive, de rechute ou d'aggravation de sa lésion professionnelle du 2 septembre 2014.

Josée Audet

M^{me} Gertrude Grenier
Pour elle-même

M^e Louis Cossette
PAQUET TELLIER
Pour la partie intervenante

Date de la dernière audience : 16 mai 2017